

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

COMUNICAZIONE OPEN DISCLOSURE DI EVENTI AVVERSI AL PAZIENTE

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO093_00	00	30/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Direttore Sanitario + Risk Manager Clinico + RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Personale Clinico + Direttore Sanitario	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente procedura definisce le modalità con cui Toscana Diagnostica S.r.l. comunica al paziente — e, ove appropriato, alla famiglia — gli eventi avversi clinici che lo abbiano coinvolto, in coerenza con il principio di Open Disclosure previsto da ISO 7101:2023 §7.4 e con le buone pratiche internazionali (Australian Open Disclosure Framework 2013; UK Being Open guidance NHS).

L'Open Disclosure è un dovere etico, deontologico e — ove configurato — anche giuridico (Legge 24/2017 "Gelli-Bianco" sulla sicurezza delle cure; Convenzione di Oviedo sui diritti del paziente). Si applica a tutti gli eventi avversi qualificati come Adverse Event con esito Mild Harm o superiore registrati nel TD-SGI-MOD209 e per i quali è stata avviata o conclusa l'analisi RCA (TD-SGI-PRO092).

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
ISO 7101:2023 §7.4 (Communication and engagement with patients and families)	Patient Engagement
Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco) art. 1 — sicurezza delle cure	Sicurezza dei pazienti — diritto alla trasparenza
Convenzione di Oviedo (1997, ratificata Italia 2001)	Diritti del paziente all'informazione
Australian Open Disclosure Framework (2013)	Best practice internazionale
UK NHS Being Open Guidance (2009)	Best practice internazionale
DM 11/01/2024 (SIMES)	Sistema Nazionale Sicurezza Pazienti
TD-SGI-MOD209 (Tassonomia ICPS)	Identificazione eventi
TD-SGI-PRO092 (SEA / RCA)	Analisi cause
TD-SGI-MOD210 (Cruscotto Patient Safety)	Tracciatura indicatori
TD-SGI-PRO040 (Comunicazione paziente — ordinaria)	Cornice generale comunicazione

3. Principi di Open Disclosure

L'Open Disclosure si fonda sui seguenti principi:

- (a) **TEMPESTIVITÀ** — la comunicazione avviene appena possibile dopo l'identificazione e la verifica preliminare dell'evento, senza ingiustificato ritardo;
- (b) **ONESTÀ** — la comunicazione descrive in modo accurato e veritiero quanto accaduto, senza minimizzazioni né dichiarazioni difensive premature;
- (c) **EMPATIA E RISPETTO** — la comunicazione tiene conto dell'impatto emotivo sul paziente e familiari; si esprime rammarico per quanto accaduto;
- (d) **TRASPARENZA** — vengono condivise le informazioni sui fatti accertati, sull'analisi delle cause (ove disponibile) e sulle azioni correttive;
- (e) **SUPPORTO CONTINUATIVO** — il paziente riceve supporto clinico, psicologico e amministrativo durante e dopo la comunicazione;

(f) APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO — l'evento è oggetto di analisi e di miglioramento, e il paziente è informato — ove appropriato — delle azioni intraprese.

L'Open Disclosure è coerente con il principio di "just culture" del SGI: NON costituisce ammissione di colpa nel senso giuridico, ma adempimento del dovere di trasparenza ex Legge 24/2017.

4. Trigger e tempistiche

Esito evento (cfr. MOD209)	Open Disclosure obbligatoria?	Tempistica
Sentinel Event (morte / grave danno permanente)	Sì — sempre	Avvio entro 24h dall'identificazione; comunicazione formale entro 5 giorni
Severe Harm (danno grave temporaneo o permanente)	Sì	Avvio entro 48h; comunicazione formale entro 7 giorni
Moderate Harm (danno significativo ma reversibile)	Sì	Avvio entro 7 giorni; comunicazione formale entro 14 giorni
Mild Harm (danno lieve)	Sì con valutazione caso per caso	Avvio entro 14 giorni
No Harm Incident con potenziale rilevante	Su decisione Risk Manager Clinico + Direttore Sanitario	Standard
Near Miss	Generalmente NO — salvo richiesta specifica del paziente o eventi sistemici	Su richiesta

5. Procedura operativa

Fase	Attività	Owner	Output
1. Trigger	Evento qualifica per Open Disclosure ai sensi del §4 — qualificazione effettuata dal Risk Manager Clinico	Risk Manager Clinico	Decisione formalizzata
2. Pianificazione comunicazione	Composizione team Open Disclosure: Direttore Sanitario (chair); medico/operatore coinvolto (se opportuno); Risk Manager Clinico; eventuale supporto psicologico; eventuale supporto legale TD	Direttore Sanitario	Team designato + agenda
3. Preparazione del paziente / famiglia	Contatto preliminare (telefono o di persona) per informare della richiesta di colloquio; chiarire chi parteciperà; rispettare la disponibilità del paziente	Direttore Sanitario	Appuntamento concordato
4. Conduzione del colloquio	Setting protetto e privato; tempo adeguato; ascolto attivo; presentazione fatti; espressione di rammarico (apologia non equivalente a confessione di colpa); risposta a domande del paziente; spiegazione delle azioni intraprese	Direttore Sanitario + medico coinvolto	Verbale del colloquio

5. Documentazione	Verbalizzazione del colloquio: presenti, oggetto, fatti comunicati, domande del paziente, risposte fornite, decisioni assunte, supporto offerto	Risk Clinico Manager	Verbale firmato dai presenti
6. Follow-up clinico	Verifica condizioni cliniche del paziente; eventuale rivalutazione diagnostica; coinvolgimento medico curante esterno; supporto continuativo	Direttore Sanitario	Piano di follow-up clinico
7. Follow-up amministrativo	Coordinamento con Assicurazione RCT (se applicabile); valutazione richiesta di rimborso/risarcimento; supporto a eventuali pratiche burocratiche	Risk Clinico + Funzione Legale Manager	Follow-up registrato
8. Aggiornamento dopo RCA	Comunicazione successiva al paziente sulle cause accertate (ad esito RCA — PRO092) e sulle azioni correttive intraprese	Direttore Sanitario	Comunicazione di aggiornamento
9. Archiviazione	Verbale + documentazione clinica + comunicazioni in archivio paziente con accesso ristretto; tracciamento nel MOD209	Risk Clinico Manager	Fascicolo paziente aggiornato

6. Tutela del paziente e supporto

TD garantisce al paziente coinvolto in un evento avverso:

- (a) supporto clinico immediato e continuativo per la gestione delle conseguenze sanitarie;
- (b) supporto psicologico — proposta di consulenza con psicologo aziendale o convenzionato (servizio gratuito);
- (c) supporto amministrativo — accompagnamento nelle pratiche di rimborso/risarcimento se applicabile;
- (d) trasparenza informativa — accesso facilitato alla cartella clinica, alle evidenze diagnostiche, agli esiti dell'RCA (compatibilmente con la riservatezza del personale coinvolto);
- (e) tutela della privacy — gestione delle informazioni in rispetto del GDPR (dati Cat. 9), accesso limitato, consenso informato per eventuali utilizzi successivi.

7. Tutela del personale coinvolto

TD applica il principio di "just culture" anche verso il personale coinvolto in eventi avversi:

- (a) supporto psicologico al personale — fenomeno "second victim" riconosciuto e gestito;
- (b) supporto legale TD nelle eventuali contestazioni;
- (c) tutela della riservatezza — l'identità del singolo operatore non è automaticamente comunicata al paziente, salvo motivata necessità;
- (d) approccio sistemico — gli errori sono analizzati come errori di sistema (Reason Swiss Cheese), non come colpa individuale, salvo casi di violazione consapevole delle procedure o negligenza grave.

8. Coordinamento con altre funzioni

Funzione	Ruolo nell'Open Disclosure
Direttore Sanitario	Conduce il colloquio principale; presidio clinico
Risk Manager Clinico	Pianificazione, documentazione, follow-up; collegamento con MOD209/PRO092
DPO	Coordinamento privacy — dati comunicati al paziente; gestione consensi
Funzione Legale (Studio Maresca)	Supporto legale — formulazione comunicazioni; gestione assicurazione RCT
Assicurazione RCT	Notifica e gestione sinistri — interlocuzione tempestiva
P&C Manager	Supporto al personale (second victim)
Comunicazione esterna	Coordinamento se l'evento ha potenziale impatto reputazionale (eccezionale)

9. KPI di processo

KPI	Target
% eventi qualificati per Open Disclosure effettivamente comunicati	100%
Tempistica media tra qualificazione e prima comunicazione	≤ tempi del §4
% colloqui con verbalizzazione completa	100%
% pazienti che richiedono follow-up secondario sull'esito RCA	Tracciato
Tasso di soddisfazione del paziente sul processo Open Disclosure (survey post)	≥ 70%
Numero di reclami formali/contenziosi avviati post Open Disclosure	Tracciato — confronto con baseline pre-PRO093
Numero ore formazione su Open Disclosure / personale clinico / anno	≥ 4h/anno

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione della Procedura di Comunicazione Open Disclosure di eventi avversi al paziente in Area 07 Rischio Clinico in attuazione di ISO 7101 §7.4 e Legge 24/2017 Gelli-Bianco. Trigger differenziati per esito (Sentinel/Severe/Moderate/Mild Harm), procedura a 9 fasi, tutela del paziente + tutela del personale (second victim), coordinamento con Direttore Sanitario, Risk Manager Clinico, DPO, Funzione Legale, Assicurazione RCT.	Direttore Sanitario + Risk Manager Clinico + RSGI	AD